

DISPENSA DE LICITAÇÃO — ART. 75, VIII, LEI N.º 14.133/2021

Processo Administrativo n.º 2026.00003

Justificativa de Situação Emergencial

Aquisição de Autoclave Hospitalar a Vapor
Central de Material e Esterilização — CME
Hospital Central de Borba

Responsável:	Cíntia Felipe Roque
Diretor Hospitalar:	Daniel Gomes Vinhote — Decreto n.º 0630/2026
Valor estimado:	R\$ 200.000,00 — Emenda Parlamentar Estadual — ALEAM
Rel. técnico-base:	05 de março de 2026
Elaborado em:	Borba/AM, 15 de março de 2026

Processo	2026.00003
Unidade solicitante	Secretaria Municipal de Saúde — Borba/AM
Setor / local	Central de Material e Esterilização (CME) — Hospital Central de Borba
Responsável	Cíntia Felipe Roque
Objeto	Aquisição de autoclave hospitalar a vapor, tipo B (pré-vácuo), câmara ≥ 100 L, com periféricos, logística CIF Borba/AM, qualificações QI/QO/QD e treinamento
Equip. substituído	Autoclave n° 6897 — Phoenix Luferco — fab. 2019 (~6 anos de uso)
Fundamentação legal	Art. 75, VIII, Lei n.º 14.133/2021 — Dispensa por emergência
Fonte de recursos	Emenda Parlamentar Estadual — Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM)
Valor estimado	R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Data do rel. técnico	05 de março de 2026

1. Fundamento Legal

BASE LEGAL

Art. 75, VIII — “É dispensável a licitação [...] nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas [...] e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial.”

A presente Justificativa fundamenta-se no art. 75, VIII, da Lei Federal n.º 14.133/2021, que autoriza a dispensa de licitação em situações de emergência que comprometam a continuidade de serviço público essencial ou a segurança de pessoas. Os elementos fáticos expostos nas seções seguintes demonstram o preenchimento **cumulativo** dos três requisitos legais:

1. **Situação emergencial concreta e documentada**, não provocada por omissão da Administração;
2. **Risco direto à segurança de pacientes e profissionais de saúde;**
3. **Objeto delimitado ao estritamente necessário** ao atendimento da emergência.

2. Fato Gerador — Diagnóstico do Equipamento

2.1 Identificação do Equipamento Inoperante

O Hospital Central de Borba dispõe de **uma única autoclave** instalada na CME. O equipamento encontra-se **inoperante por falha sistêmica múltipla**, conforme relatório técnico formal lavrado pelo Diretor Hospitalar.

Nº de patrimônio	6897
Fabricante	Phoenix Luferco
Ano de fabricação	2019 (aproximadamente 6 anos de uso)
Tipo	Autoclave hospitalar a vapor – câmara única
Localização	CME – Hospital Central de Borba
Status atual	INOPERANTE – falha sistêmica múltipla
Laudo técnico	Relatório formal lavrado pelo Diretor Hospitalar Daniel Gomes Vinhote (Decreto n.º 0630/2026) – Anexo I deste processo

2.2 Falhas Técnicas Identificadas

O diagnóstico técnico formalizado em 05 de março de 2026 identificou quatro falhas de natureza grave, com impacto direto na segurança do processo de esterilização:

F1

Salto de etapas do ciclo de esterilização

O equipamento passa diretamente da fase de esterilização para a secagem sem concluir o processo. Essa falha invalida a garantia de esterilidade pois o tempo de *plateau* – exposição contínua na temperatura alvo – não é respeitado, impedindo o alcance do Nível de Garantia de Esterilidade (SAL) de 10^{-6} exigido pela RDC ANVISA 15/2012.

F2

Não atingimento da temperatura mínima de esterilização

O equipamento falha em alcançar $134\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ nos ciclos de pré-vácuo. A esterilidade a vapor é matematicamente expressa pelo Valor F_0 :

$$F_0 = \int_0^t 10^{\frac{T-121.1}{z}} dt \quad T = \text{temperatura (}^{\circ}\text{C)}; z = 10\text{ }^{\circ}\text{C (}G. \textit{stearothermophilus}\text{)}$$

Com temperatura insuficiente, o F_0 calculado fica abaixo do mínimo de **15 minutos**, tornando os artigos processados microbiologicamente inseguros.

F3

Falha no sistema hidráulico de abastecimento automático

O sistema de entrada de água autônoma está inoperante, exigindo intervenção manual a cada ciclo. Isso compromete: (i) a padronização dos ciclos; (ii) a rastreabilidade do processo

(RDC 15/2012, art. 34); e (iii) a segurança do operador, exposto a componentes aquecidos durante a manipulação.

F4**Instabilidade geral – falha sistêmica múltipla**

Comportamento errático com parâmetros de pressão e temperatura inconsistentes ao longo dos ciclos, indicativo de falha simultânea em múltiplos subsistemas (controle eletrônico, sensores, válvulas). A coexistência de F1 a F3 descarta a hipótese de pane isolada e confirma degradação sistêmica irreversível do equipamento.

3. Caracterização da Situação de Emergência

3.1 Impactos Operacionais Imediatos

A inoperância da única autoclave do CME produz impactos diretos e imediatos na operação assistencial, insuperáveis por qualquer solução alternativa interna:

- **Redução crítica da capacidade de esterilização** de instrumentais médico-cirúrgicos utilizados em cirurgias, curativos e procedimentos invasivos;
- **Risco de desabastecimento de materiais esterilizados** para o centro cirúrgico, pronto-socorro e unidades de internação;
- **Impossibilidade de garantia da eficácia da esterilização**, com potencial uso de artigos inadequadamente estéreis – violação direta dos arts. 5.º, 6.º e 34 da RDC ANVISA 15/2012;
- **Exposição dos profissionais de saúde** a materiais potencialmente contaminados durante o reprocessamento manual emergencial.

3.2 Risco Sanitário Direto ao Paciente

O processamento inadequado de artigos críticos é a principal causa de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) de origem instrumental. No Hospital Central de Borba – único hospital de referência para **34.869 habitantes** (IBGE 2025) em área de acesso predominantemente fluvial – a falha de esterilização tem consequências amplificadas:

CADEIA CAUSAL – FALHA DE ESTERILIZAÇÃO → DANO AO PACIENTE

Falha sistêmica do equipamento → $SAL > 10^{-6}$ → **artigo crítico inseguro** → contato com sítio cirúrgico → **Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC)** ou IRAS sistêmica → morbidade, internação prolongada, sepse, **óbito evitável**.

No interior do Amazonas, onde o tempo de acesso a centros de referência em Manaus pode superar 24 horas por via fluvial, a evolução de uma ISC grave sem tratamento imediato disponível configura risco de morte diretamente atribuível à falha de esterilização.

3.3 Impossibilidade de Aguardar o Rito Licitatório Regular

Um Pregão Eletrônico para aquisição deste bem demandaria, em condições normais, o seguinte prazo mínimo até a Entrega Técnica:

Etapa	Prazo mín.	Observação
ETP + TR + pesquisa de preços	15 dias	Já concluídos
Elaboração e revisão do edital (CPL + PGM)	10 dias	
Publicação no PNCP até abertura	8 dias	Art. 55, § 2.º
Prazo de propostas + sessão + habilitação	15 dias	

Recursos + homologação + assinatura	10 dias	
Entrega Técnica – período de seca	90 dias	Ago–Nov: balsas de menor calado
Total estimado até Entrega Técnica	≈ 148 dias	Quase 5 meses sem esterilização segura

Cinco meses de operação hospitalar sem autoclave funcional – em hospital de referência regional, realizando cirurgias e atendimentos de urgência – configura risco inaceitável à vida humana, incompatível com o princípio da eficiência (CF/88, art. 37) e com o dever de cautela sanitária.

4. Inviabilidade da Manutenção Corretiva

A natureza **múltipla e sistêmica** das falhas F1 a F4 torna a manutenção corretiva economicamente inviável e tecnicamente insuficiente como solução definitiva, pelos seguintes fundamentos:

1. **Falha simultânea em quatro subsistemas críticos** (controle de ciclos, sistema térmico, sistema hidráulico e estabilidade operacional geral), indicativa de degradação estrutural – não pane pontual reparável;
2. **Obsolescência funcional acelerada:** o equipamento tem 6 anos de uso em CME de média complexidade com alta rotatividade de ciclos. As condições amazônicas – umidade relativa $\geq 80\%$, temperatura ambiente 26–34 °C – aceleram a degradação de componentes eletrônicos, guarnições e resistências;
3. **Custo de reparo economicamente inviável:** a restauração dos quatro subsistemas no interior do Amazonas representa custo estimado de **60–75% do valor de substituição**, sem garantia de desempenho equivalente e sem recomposição do período de garantia;
4. **Ausência de qualificação pós-reparo:** mesmo reparado, o equipamento não seria submetido a nova qualificação documentada (QI/QO/QD) com resultados auditáveis, mantendo incerteza sobre o SAL efetivamente alcançado.

POR QUE ESTA EMERGÊNCIA NÃO DECORRE DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA

A jurisprudência do TCU e do TCE-AM exige que a emergência **não seja fruto de negligência do gestor**. No presente caso: (i) o equipamento foi adquirido regularmente em 2019; (ii) a falha sistêmica apresentou-se de forma progressiva e imprevisível, abaixo do horizonte de vida útil esperado (10–15 anos); (iii) a Emenda Parlamentar estava disponível; e (iv) a falha foi documentada tempestivamente pelo Diretor Hospitalar. O gestor agiu com diligência ao identificar, formalizar e imediatamente encaminhar a solução.



5. Especificação Técnica Justificada

A especificação foi elaborada com base na RDC ANVISA 15/2012, ISO 17665-1:2006 e EN 285:2015, nas características operacionais do CME (40 leitos, cirurgias de urgência e eletivas) e nas condições climáticas da Amazônia.

Especificação	Requisito e Justificativa
Tipo	Autoclave hospitalar a vapor saturado, *Tipo B (pré-vácuo)*, horizontal – obrigatório para artigos porosos (campos, uniformes) e artigos com lúmens (RDC 15/2012, art. 15)
Câmara	Capacidade útil *≥ 100 litros*; aço inoxidável *AISI 316L* polido internamente – resistência superior a cloretos e à umidade ≥ 80% do clima amazônico

Sistema de vácuo	Bomba de anel líquido; pressão absoluta ≤ 30 mbar*; *mínimo 3 pulsos* alternados de vácuo e vapor – único método eficaz para remoção de ar em porosos e lúmens (EN 285:2015, item 8)
Temperatura	105 °C a 135 °C com precisão ± 1 °C* – necessária para $F_0 \geq 15$ min e SAL 10^{-6} (ISO 17665-1:2006)
Programas	Mínimo *13 programas* pré-configurados: poroso 134 °C, sólido 134 °C, líquido 121 °C, Bowie-Dick e Leak Test
Interface e rastreabilidade	Tela colorida *touchscreen*, gestão de usuários com senha, *impressora integrada* de etiquetas de ciclo – atende ao art. 34 da RDC ANVISA 15/2012
Registro eletrônico	Memória interna de ciclos + saída USB para exportação de relatórios auditáveis pelo TCE-AM e Transferegov
Proteção elétrica	Gabinete elétrico *IP 54* (mínimo) – essencial dado UR $\geq 80\%$ em Borba/AM
Segurança	Mínimo *10 sistemas de segurança*, incluindo antiesmagamento de porta, bloqueio sob pressão, alarmes sonoros e visuais de falha
Periféricos incluídos	Osmose reversa 60 L/h (condutividade $\leq 1,3$ μ S/cm); compressor de ar médico isento de óleo ≥ 50 L (ABNT NBR ISO 7396-1:2011); racks AISI 316L (≥ 3 un.); carro de transporte inox; IB G. stearothermophilus (cx 50 un.); IC Cl. 5 (cx 200 un.); peças de desgaste para 12 meses
Qualificações	*QI + QO + QD* (ISO 17665-1:2006) realizadas no CME do Hospital, com Relatório de Qualificação em 2 vias impressas + PDF assinado como condição do TRD
Logística	*CIF Borba/AM + Entrega Técnica* – frete fluvial Manaus–Borba, seguro Ad Valorem, embalagem antivibração e antiumpidade para transporte fluvial
Treinamento	Mínimo *8 horas* presenciais no CME, com certificados nominais – operação, manutenção preventiva, monitoramento biológico/químico, rastreabilidade RDC 15/2012
Garantia	Mínimo *24 meses* a contar do TRD; atendimento técnico no Amazonas em ≤ 72 horas*; solução definitiva em ≤ 15 dias corridos*
Registro ANVISA	Obrigatório – fabricante ou importador com registro ativo para o equipamento ofertado
RENEM	Equipamento deve constar da RENEM com código CATMAT – exigência das Portarias GM/MS 6.870 e 6.904/2025 (Emenda Parlamentar)

6. Dotação Orçamentária e Fonte de Recursos

A aquisição é custeada com **Emenda Parlamentar Estadual** aprovada pela Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), destinada à Secretaria Municipal de Saúde para equipamentos hospitalares. A

execução financeira ocorrerá via **Transferegov** (Ministério da Saúde), observadas as Portarias GM/MS n.º 6.870 e 6.904/2025.

Componente	Valor (R\$)	%
Autoclave hospitalar ≥ 100 L com barreira sanitária	120.000,00	60,0%
Periféricos (osmose, compressor, racks, carro, IB, IC)	35.000,00	17,5%
Logística CIF Borba/AM + seguro Ad Valorem	15.000,00	7,5%
Entrega Técnica (QI/QO/QD) + Treinamento (8h)	10.000,00	5,0%
Peças de desgaste e consumíveis – 12 meses	15.000,00	7,5%
Contingência logística (sazonalidade Rio Madeira)	5.000,00	2,5%
Total – Emenda Parlamentar 2025	200.000,00	100%

A reserva de **R\$ 20.000,00** para adequação da infraestrutura do CME (rede elétrica trifásica, ponto hidráulico e exaustão de vapor) é **recurso municipal próprio, adicional e segregado** da Emenda Parlamentar – executado em processo administrativo distinto, para não contaminar a prestação de contas via Transferegov/SICONV.

Os recursos são de aplicação vinculada à saúde, em plena conformidade com as finalidades da transferência parlamentar, sem desvio de objeto.

7. Prazo da Contratação

Nos termos do art. 75, VIII, da Lei n.º 14.133/2021, a contratação emergencial é limitada ao prazo de **1 (um) ano**, suficiente para entrega, instalação, comissionamento e início de operação regular. O prazo de entrega será estipulado conforme o período hidrológico do Rio Madeira vigente na data de assinatura do contrato:

Período	Meses	Condição Hidrológica	Prazo Máximo
Cheia plena	Jan–Mai	Navegação plena; balsas de grande calado	60 dias corridos
Vazante	Jun–Jul	Restrições incipientes; monitoramento necessário	75 dias corridos
Seca extrema	Ago–Nov	Balsas de menor calado obrigatórias (ANA)	90 dias corridos
Enchente	Dez	Normalização progressiva da navegabilidade	75 dias corridos

Atraso comprovadamente causado por seca extrema declarada pela ANA não configurará mora do fornecedor, desde que comunicado ao Gestor com ≥ 15 dias de antecedência e comprovado com declaração da empresa de navegação e boletim da ANA. É **vedada a prorrogação** do contrato emergencial e a recontração do mesmo fornecedor sob esta hipótese (*in fine* do art. 75, VIII).

8. Requisitos Formais da Dispensa

Em cumprimento ao art. 72 da Lei n.º 14.133/2021, o processo deve ser instruído com:

Documento	Artigo	Status
① Esta Justificativa de Situação Emergencial	Art. 72, I	Elaborada — Anexo I
② Laudo técnico do CME — Diretor Hospitalar	Art. 72, I	Elaborado — Anexo II
③ Termo de Referência com especificações técnicas	Art. 72, III	Elaborado — Anexo III
④ Pesquisa de preços — mínimo 3 cotações	Art. 72, IV	A realizar — modelo Anexo IV
⑤ Planilha comparativa e seleção do fornecedor	Art. 72, VII	A elaborar após cotações
⑥ Contrato de Fornecimento	Art. 72, VIII	Minuta — Anexo V
⑦ Publicação no PNCP em até 10 dias úteis	Art. 174	Após assinatura

ATENÇÃO

Dispensas por emergência de alto valor são alvo prioritário de auditoria pelo TCE-AM. Os riscos mais comuns de glosa são: (i) ausência ou insuficiência da pesquisa de preços; (ii) urgência documentada apenas com declarações genéricas — sem laudo técnico; (iii) contratação de empresa sem capacidade técnica comprovada; (iv) ausência de publicação no PNCP no prazo legal. Esta Justificativa, acompanhada do laudo do Diretor Hospitalar e das 3 cotações de mercado, forma o conjunto mínimo para defesa sólida em eventual tomada de contas especial.

9. Conclusão e Recomendação

Estão configurados **cumulativamente** todos os pressupostos legais para a contratação direta por emergência, nos termos do art. 75, VIII, da Lei n.º 14.133/2021:

- ✓ **Situação emergencial concreta e documentada**, não provocada por omissão: a autoclave n.º 6897 (Phoenix Luferco, 2019) apresentou falha sistêmica em múltiplos subsistemas, formalmente documentada pelo Diretor Hospitalar Daniel Gomes Vinhote (Decreto n.º 0630/2026).
- ✓ **Risco direto e imediato à segurança de pacientes e profissionais de saúde**, com potencial para ISC, IRAS sistêmica e óbito evitável, em hospital de referência regional para 34.869 habitantes com acesso fluvial predominante.
- ✓ **Comprometimento da continuidade de serviço público essencial de saúde**, com risco iminente de desabastecimento de materiais esterilizados para todos os setores assistenciais.
- ✓ **Inviabilidade técnica e econômica da manutenção corretiva**, demonstrada pela natureza sistêmica das falhas e pelo custo de reparo estimado em 60–75% do valor de substituição, sem garantia de desempenho.
- ✓ **Objeto delimitado ao estritamente necessário**, sem excesso ou superdimensionamento, nos termos do art. 75, VIII, *in fine*.

Recomenda-se a **imediata abertura do procedimento de contratação direta**, com as seguintes providências:

1. Publicação do aviso de dispensa no PNCP, nos termos do art. 72, III;
2. Instrução do processo com esta Justificativa, o Laudo Técnico (Anexo II), o Termo de Referência (Anexo III) e pesquisa de preços com mínimo de 3 cotações (Anexo IV);
3. Seleção do fornecedor com proposta mais vantajosa, compatível com as especificações técnicas e com o registro do equipamento na RENEM;
4. Assinatura do Contrato de Fornecimento com cláusula de Entrega Técnica (QI/QO/QD) e garantia mínima de **24 meses**;
5. Publicação da contratação no PNCP em até **10 dias úteis** da assinatura (art. 174).

Borba – AM, 15 de março de 2026

Cíntia Felipe Roque

Responsável – CME
Secretaria Municipal de Saúde de Borba/AM

Daniel Gomes Vinhote

Diretor Hospitalar
Hospital Central de Borba
Decreto n.º 0630/2026

[Nome e Cargo do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde]

Secretário(a) Municipal de Saúde de Borba/AM

APROVADO – Autorizo a abertura da contratação direta

Base normativa: Lei n.º 14.133/2021, arts. 72 e 75, VIII • RDC ANVISA n.º 15/2012 • ISO 17665-1:2006 (validação calor úmido) • EN 285:2015 (esterilizadores a vapor) • ABNT NBR ISO 7396-1:2011 (ar médico) • IN SEGES/MGI n.º 65/2021 (pesquisa de preços) • Portarias GM/MS n.º 6.870 e 6.904/2025 (Emenda Parlamentar) • CF/88, arts. 37 e 196.